



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : ثناء عبدالسميع حسن حسين

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : الصف

العنوان : .

رقم البطاقة : 26412202103604 رقم التليفون : 01224721415

تاريخ تسجيل الإستمارة : 22-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 20-12-1964 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ثناء عبد السميع حسن حسين National ID: 26412202103604	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية



02/22/2026

MDT FORM

Name:	Thanaa Abd Elsamiea Said Hessen	MRN:	7790
Age:	61 Y	ID:	
Menopausal Sta	post	Phone:	01122081166
NRS SCORE:		Marital Status:	+ve FH (sister)
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	HTN , DM	Reason Of MDT:	new

Clinical Data:

BX: mixed invasive duct and lobular carcinoma

ER: 8/8 **PR:** 6/8 **HER2:** 1+ **KI67:** 15%

R

L

Sonomammography:

ACR B
lt breast retroareolar mass 10x8 mm with internal microcalc (BIRADS V)

Mets Workup:

CT : free

History:

CESM : lt extensive pathological proved neoplastic process (10x 11 cm)
multiple at least 3 pathological axillary LNs

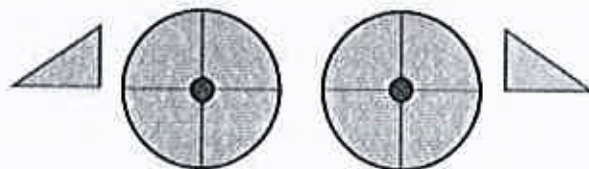
Recommendations:

clinically: LT upper central diffuse mass + skin edema but not redness
for possibility of neoadj ttt then LT MRM

omnia essayy

MDT Outcome & Plan

FOR NCTH ACX3 TXT X3 THEN LT MRM (DJF, MICROCALCIFICATION)

**T N M****SIGNATURE**

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
Mohamed Elhikay	Dr. Ahmed Elhikay	Dr. Mohamed Elhikay			



رسوم الاستعلام 20 جنية

جبهة الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2025-12-7

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) ثناء عبد السميع حسن بطاقة رقم 26412202103604

تليفون رقم: 01158827970

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ان يكون مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2025-12-7



افادة مركز نظم المعلومات
بمتمدد،،،



مسلسل 1845833

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي



Name of patient : Sanaa Abdelsamee

Date of examination: 6-12-2025

Bilateral breast sono-mammography revealed:-

• **Mammography:**

• **ACR: b**

• **Left breast** showing extensive retro-areolar area of spiculated heterogeneity (measuring about 10x8mm) with internal microcalcifications seen with overlying skin thickening is seen

• **By US:** showing retro-areolar spiculated extensive area of ill-defined heterogeneity with overlying edematous skin & ipsilateral suspicious axillary LNs where thickened peripherally located cortex, measuring up to 3.9mm

• **Rt breast** showing diffuse homogenous density, showing No evidence of suspicious micro calcification, No evidence of solid masses nor densities

• **By US: Rt breast is** showing diffuse echogenic mottled breast parenchyma with no evidence of cysts nor solid masses seen

• Rt axilla showing reactive LNs with preserved fatty hila

Conclusion:

• Left breast malignant mass with ipsilateral suspicious axillary LNs (BIRADs V)

Dr/ Nashwa Elsayed.Msc

Patient ID: 90470	Patient Name English: Thanaa Abdalsami Hassan Hussein
Age: ٤٠ سنة, ١١ شهر	Report Date: 2025/12/07 09:27:37 AM

Women's Health Outreach Program

Left Full field breast ultrasound

High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast

- An ill defined area of altered parenchymal hyperechogenicity seen at 12 o'clock parareolar measuring about 3.2x1.4 cm with nipple extension and nipple retraction and overlying skin thickening
- No other solid or cystic lesion
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Few suspicious looking axillary lymph nodes globular in shape with cortical thickening about 4 mm

Impression:

Left breast (BIRADS 5): a 12 o'clock parareolar suspicious looking area with ipsilateral suspicious looking axillary lymph nodes

Norhan osama,MD

Patient ID: 91942	Patient Name English: Thanaa Abdalsami Hassan
رقم المريض Age:	2025/12/29 11:57:12 AM :Report Date

Contrast Enhanced Digital Mammography

Clinical summary: left pathological proved mixed invasive duct & lobular carcinoma

Technique

MLO and CC views (low energy & recombined post contrast)

Targeted High resolution ultrasound

Detailed Findings:

Density: ACR C

Background Uptake: minimal

Right breast

- Low energy (non contrast images) show : no masses, asymmetry, distortion or suspicious calcifications.
- Recombined (post contrast) images show: no pathological uptake.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic masses.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Low energy (non contrast images) show : regional coarse heterogeneous microcalcifications and diffuse moderate skin thickening and interstitial edema.
- Recombined (post contrast) images show: multiple confluent areas of heterogeneous non mass enhancement being crescentic shape more intense at upper quadrants over all measuring about 10x11 cm and 10 mm from nipple.
- Ultrasound demonstrated multiple areas of heterogeneous pathological hypoechoic parenchyma almost involving the whole breast being more evident at UOQ and UIQ .
- Multiple at least 3 small rounded pathological axillary lymph nodes with effaced hilum seen at level I , largest measuring 5 mm and cortical thickness reaching 4mm .

Impression:

Left breast (BIRADS 6): left breast extensive pathologically proved neoplastic process (mixed IDC and invasive lobular carcinoma) with metastatic lymph nodes at level I.

Right breast (BIRADS 1): Normal

Dr. Lamiaa Adel MD

DR/Marwa

Abdelhakim ,msc

Patient Name : الأستاذ / ثناء عبدالسميع حسن	Request No. : 13003837
Patient No. : 26412202103604	Request Date : 07/12/2025
Path No. : 3783/25	Verification Date : 14/12/2025
Sex : Female	Financial Category : جومستاف روسي - مبادره
Age : 60 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 07/12/2025, at 11:45 am.

Gross Examination:

- Five fragmented grey white tissue cores, the longest is 1.5 cm, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for:

- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

* Histological type: Mixed invasive duct & invasive lobular carcinoma.

* Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).

* DCIS: Focal low & intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid pattern with comedo type necrosis).

* LCIS: Focal.

* Microcalcification: Present.

* Angioinvasion: Present.

* Perineural invasion: Absent.

* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).

- PR: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (score 6/8).

- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).

- Ki67%: 15%.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 14/12/2025 12:23:16

Page 1 of 3

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name : SANAA ABD AL SAMIA

Branch : Portable

Ref.Physician Prof :

Date : 10-01-2026 11:15

Medical No. : GRI-26412202103604

Ins.Company :

**MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST
ABDOMEN AND PELVIS:**

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction. .

FINDINGS:

(I) Chest:

- ☐ Left breast skin thickening with maximum thickness 13 mm with underlying architectural distortion
- ☐ multiple enlarged left axillary lymph nodes , the largest measures 11 x 10 mm
- ☐ few prevascular enlarged lymph nodes , measures 17 x 6 mm.
- ☐ Patent central air ways with well inflated both lungs.
- ☐ Mosaic perfusion of both lung lobes.
- ☐ Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- ☐ No CT evidence of hilar lymph node enlargement.
- ☐ No pleural or pericardial collections seen.
- ☐ No gross cardiac abnormality. Mosaic perfusion of both lower
- ☐ Mosaic perfusion of both lower lung lobes

(II) Abdomen and pelvis:

Name : SANAA ABD AL SAMIA

Branch : Portable

Ref.Physician Prof :

Date : 10-01-2026 11:15

Medical No. : GRI-26412202103604

Ins.Company :

- ☐ The liver is average in size showing homogenous CT density with no enhancing focal lesions
- ☐ No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- ☐ Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- ☐ Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- ☐ Unremarkable other pelvic organs.
- ☐ No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- ☐ No ascites.
- **(III) Examined skeleton:**
 - ☐ No worrisome lytic or sclerotic bony lesions .
 - ☐ No vertebral structural collapse or wedging.

OPINION:

- ☐ No pulmonary , hepatic or boy metastatic deposits.

Dr. Reham Khedr, MD

Patient's Name: Thanaa Abdelsamie Hassan Hussein
Date: 2026-09-05
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Pathologically proven left breast cancer, post NACT assessment study.

Findings:

Right breast.

- Scattered densities of glandular tissue . (ACR B)
- No speculations ,assymtery ,or suspicious microcalcifaitions ..
- Vascular calcification s.
- **Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions .**
- Non specific axillary lymph nodes .

Left breast.

- Scattered densities of glandular tissue . (ACR B).
- **Thickened left breast skin associated with underlying infiltrative mass with coarse heterogenous calcification occupying the central part of the breast over area of (8 x 8 cm)**
- **Ultrasound demonstrated thickened skin with heterogenous infiltrated parenchyma in the central part of the breast being more evident in the left UOQ .**
- **Multiple (more than 3 in number) suspicious looking levels 1 ,2 and 3 the largest measures (10 x 8 mm) with thick cortex of 4 mm .axillary LNs.**

Conclusion:-

- Left breast (BIRADS 6): Comparing to the availble data findingd are suggestive of nearly stable disease (decrease less than 30%)..

- Right breast (BIRADS 1): Normal .

Prof.MONA ZAKY

مركز
السرطانمركز
السرطانمركز
السرطان

08/26/2026

MDT FORM

Name:	Thanaa Abd Elsamia Said Hessen	MRN:	7790
Age:	62 Y	ID:	26412202103604
Menopausal Sta	postm	Phone:*	01100776460
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
Gender		Reason of MDT:	post neoadjuvant
CO Morbidity:		ECOG Performance Status	0 1 2 3 4
Surgical History:*	none		

Clinical Data:

BX:	idc & ilc g2
ER:	8/8
PR:	6/8
HER2:	-ve
KI67:	15
History:	postm left breast cancer ct4b n1 mo by cts idc ilc 2 er8/8 pr6/8 her2-ve ki
Sonomammography:	pt rec nact 3 ac 9 weeks taxol last 15/8/2026
Biomarker/Molecular	
Metis Workup:	
Recommendations:	for lt mrm as planned (dr /hubway)
MDT Outcome & Plan	LT MRM (DIFFUSE MICROCALCIFICATIONS)
SIGNATURE	
Pathological Staging:	
Clinical Staging:	
Right Side	Q1 Q2 Q3 Q4
Left Side	Q1 Q2 Q3 Q4
T N M	

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
------------------	---------	-----------	-----------